L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama:

a) la seguente normativa statale:

a.1_il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali);

a.2_il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, i quali disciplinano che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche attraverso l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture che erogano prestazioni o esercitano attività sanitarie;

a.3_la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, che stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

a.4_il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);

a.5_il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);

a.6_il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e, in particolare, gli articoli 29 e 30, rispettivamente rubricati "Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario" e "Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti";

a.7_il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria);

a.8_il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale);

a.9_la legge 23 marzo 2023, n. 33 (Delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane);

a.10_il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33) e, in particolare, l'articolo 31, in materia di "Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari";

b) i seguenti Accordi:

b.1_l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 160/CSR del 15 settembre 2016), concernente il Piano nazionale delle cronicità;

b.2_l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2019 (Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019), concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;

c) la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023, recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025", che prevede, tra l'altro, la riorganizzazione dell'assistenza territoriale e in particolare della rete di strutture residenziali socio-sanitarie per livelli di impegno sanitario;

d) la seguente normativa regionale:

d.1_la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

d.2_la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 19 (Contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative), il quale, disciplinando i requisiti di residenza per la concessione, prevede l'erogazione di "*contributi per il pagamento di rette in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative pubbliche o private a favore di persone non autosufficienti, affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al loro domicilio, al fine di garantire alle medesime un'adeguata assistenza"*;

e) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

e.1_ n. 2418 in data 25 agosto 2006, recante "Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie nell'ambito di strutture pubbliche e private destinate a residenze sanitarie assistenziali (RSA) e ad unità di assistenza prolungata (UAP), ai sensi dell'art. 38 della l.r. 25/1/2000, n. 5 e della DGR in data 21.6.2004, n. 2103. Revoca della DGR n. 3898 in data 23.11.2005";

e.2_ n. 2825 in data 12 ottobre 2007, concernente l'approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'Unità di Assistenza Prolungata (UAP) dell'APS G.B. Festaz di Aosta mediante sostituzione del punto 2 dell'allegato C) alla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 19 gennaio 2007, recante approvazione delle direttive e delle Modalità di erogazione dei finanziamenti all'APS G.B. Festaz di Aosta, già modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1507 del 1° giugno 2007;

e.3_n. 2894 in data 2 dicembre 2011, recante "Revisione delle tariffe relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e all'Unità di Assistenza Prolungata (UAP). Modificazione delle DGR 2418/2006 e 2825/2007 - Revoca DGR 1472/2011";

e.4_ n. 70 in data 25 gennaio 2019, recante "Recepimento del Piano nazionale della cronicità di cui all'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 15 settembre 2016 e istituzione di un tavolo di lavoro per la predisposizione delle linee di indirizzo regionali";

e.5_n. 296 in data 22 aprile 2020, recante "Approvazione dell'attivazione di un'Unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive presso la struttura sita nel Comune di Perloz sino al permanere dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19";

e.6_n. 338 in data 28 marzo 2022, recante "Approvazione di indicazioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta concernenti l'attività socio-sanitaria erogata presso le strutture residenziali di Perloz, Variney e Morgex;

e.7_n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante "Approvazione del documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire

le associazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle unità complesse di cure primarie (UCCP), ai sensi degli accordi collettivi nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della DGR 1304/2008", con la quale si definisce la programmazione dell'assistenza territoriale secondo gli standard ed il modello di assistenza definito con il DM 77/2022 e, in particolare, l'allegato A, paragrafo dedicato, nel quale si delineano le attività future per l'assistenza domiciliare integrata, scandendone le scadenze nel correlato cronoprogramma, allegato, a sua volta, alla DGR medesima;

e.8_n. 722 in data 23 giugno 2023, recante "Approvazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per lo svolgimento delle cure domiciliari di livello base, di I, II, e III livello in recepimento dell'Intesa (Rep. Atti n. 151/CSR) in data 4 agosto 2021";

e.9_n. 1677 in data 23 dicembre 2024, recante "Approvazione di determinazioni per l'organizzazione della rete delle cure palliative";

e.10_n. 1182 in data 30 dicembre 2024, recante "Aggiornamento del fabbisogno complessivo di assistenza in ambito regionale di cui alla DGR 348/2023 e approvazione dell'atto programmatorio regionale per il triennio 2025/2027. Recepimento degli accordi stato-regioni relativi alla Procreazione Medicalmente Assistita e disposizioni in merito alla rete regionale di offerta di diagnostica di laboratorio";

f) il documento tecnico "Prestazioni residenziali e semi-residenziali", approvato in data 30 maggio 2007 dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza in capo alla Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della Salute, che definisce i contenuti tecnico-professionali delle prestazioni citate;

g) il documento redatto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) dal titolo *"Sistemi di remunerazione dell'assistenza domiciliare, residenziale e semi-residenziale. Analisi comparative delle tariffe vigenti a livello regionale"*, pubblicato all'interno della collana "Quaderni Monitor";

h) la proposta del Ministero della Salute in corso di istruttoria concernente "Criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l'individuazione dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali e semi-residenziali per persone anziane non autosufficienti in attuazione dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29", dalla quale sono state desunte alcune indicazioni concernenti il nucleo per i trattamenti di lungoassistenza e mantenimento R3.

Ritiene necessario, come proposto dai referenti dei competenti uffici dell'Assessorato, aggiornare i requisiti organizzativi di cui alla DGR 2418/2006 sopra citata, in considerazione dell'evoluzione sia del sistema di offerta di strutture residenziali avvenuto negli ultimi anni, sia delle funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti alle figure professionali operanti nelle strutture residenziali RSA e UAP disciplinate dalla DGR medesima, alla luce degli attuali bisogni clinici e assistenziali degli utenti eleggibili per l'inserimento nella tipologia di strutture di cui trattasi.

Evidenzia la necessità, rappresentata dai competenti uffici regionali, con riferimento all'Unità di assistenza prolungata (UAP) di cui all'allegato B alla DGR 2418/2006, che eroga trattamenti assimilabili a quelli previsti dai livelli essenziali di assistenza all'articolo 29 del DPCM 12 gennaio 2017, in favore di utenti in gravissime condizioni e in completa non autosufficienza, che hanno superato la fase acuta, ma che necessitano di ricovero in strutture non ospedaliere, di aggiornare i requisiti e la tariffa di cui alla DGR 2418/2006 medesima, come indicato nell'allegato A alla presente deliberazione.

Sottolinea inoltre che, con riferimento al nucleo Residenza Sanitaria Assistenziale RSA, le disposizioni di cui alla DGR 2418/2006, allegato A, sono già state in parte superate dalla DGR 296/2020 e dalla DGR 338/2022 sopra richiamate, con le quali, tra l'altro, si riclassifica l'attività di RSA in attività di unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive R2.

Precisa che, secondo quanto riferito dai competenti uffici dell'Assessorato, è necessario procedere con un ulteriore aggiornamento dei requisiti organizzativi per l'erogazione di attività di unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive R2 di cui alle richiamate DGR 296/2020 e 338/2022, in quanto quelli ad oggi vigenti fanno ancora esplicito riferimento alla pandemia da SARS-COV-2, approvando le indicazioni in materia contenute nell'allegato B alla presente deliberazione, comprensive di tariffa aggiornata.

Rileva altresì la necessità, riferita dai referenti degli uffici competenti, di disciplinare i requisiti organizzativi e definire la tariffa per l'erogazione di attività di unità socio-sanitaria di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi gli interventi di sollievo per chi assicura le cure a persone non autosufficienti, riconducibile al codice R3 di cui all'allegato C alla presente deliberazione.

Precisa che ad oggi non sono presenti sul territorio regionale strutture residenziali di tipo socio-sanitario che eroghino tale tipologia di trattamento, la quale, tuttavia, si configura quale setting assistenziale da rendere disponibile nell'ambito delle attività in corso, finalizzate a riorganizzare e potenziare la rete dell'assistenza territoriale residenziale, per rispondere alle necessità cliniche degli assistiti, in coerenza con quanto previsto nella programmazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025.

Propone, pertanto, di approvare i requisiti organizzativi e le tariffe per l'erogazione di attività di unità socio-sanitaria di cure residenziali di cui agli allegati A, B e C alla presente proposta di deliberazione.

Dà atto che i contenuti di cui agli allegati alla presente deliberazione sono l'esito del confronto tra i referenti competenti dell'Assessorato e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Dà, altresì, atto che l'approvazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto illustrato in premessa, i requisiti organizzativi e le tariffe per l'erogazione delle attività di unità di assistenza prolungata (UAP) di cui all'allegato A alla presente deliberazione, di unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive R2, di cui

all’allegato B alla presente deliberazione, nonché di unità socio-sanitaria di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, riconducibile al codice R3, di cui all’allegato C alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;

3. di revocare le DGR n. 2418/2006, n. 2825/2007 e n. 2894/2011;

4. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, alla Struttura organizzativa finanziamento del servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari, all’Azienda USL della Valle d’Aosta e all’Organismo Tecnicamente Accreditante presso l’Agenzia Regionale Per l’Ambiente della Valle d’Aosta.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 7 luglio 2025

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA DI UNITÀ DI ASSISTENZA PROLUNGATA (UAP).

1. Tipologia di assistenza e obiettivi

Si definisce Unità di assistenza prolungata (UAP) il nucleo riservato a persone che hanno superato la fase acuta, ma che necessitano di inserimento in struttura non ospedaliera, ove sia garantita l'appropriata assistenza sanitaria.

Rientrano tra le persone ammesse in una UAP coloro che, in presenza di malattia stabilizzata, sono in stato di completa dipendenza oppure hanno un grado di autonomia minima.

I trattamenti erogati nell'UAP, riconducibili a quelli ricompresi nei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 29 "Assistenza residenziale extra-ospedaliera ad elevato impegno sanitario" del DPCM 12 gennaio 2017, sono trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale, in quanto in stato di completa dipendenza o aventi grado di autonomia minima. I trattamenti sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e consistono in prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per la nutrizione artificiale e dei dispositivi medici previsti dalle disposizioni vigenti.

La UAP si colloca nella rete di strutture e servizi di assistenza territoriale prevista dalla programmazione del Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2022-2025 e dalle disposizioni di cui alla DGR 1609/2022, finalizzata a garantire continuità di cura nella fase intermedia tra il ricovero ospedaliero e l'assistenza domiciliare (o viceversa), orientata principalmente al consolidamento dello stato clinico generale e dei risultati terapeutici ottenuti.

2. Modalità di inserimento/accesso e durata dell'inserimento

Nell'ambito dell'attività svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale gli inserimenti presso l'UAP sono disposti dalla Centrale Operativa Territoriale (COT), nel rispetto dei criteri di eleggibilità dell'utente segnalato dal medico inviante e dall'infermiere di riferimento (medico specialista ospedaliero anche extra regionale, referente clinico dell'utente se inserito in strutture residenziali, medico di medicina generale se l'utente proviene dal domicilio).

Possono essere inseriti presso l'UAP utenti provenienti da:

- strutture ospedaliere, strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche extra regionali;
- domicilio.

L'inserimento presso l'UAP è subordinato all'iscrizione dell'utente al Servizio Sanitario Regionale e, allorquando gli utenti non siano residenti in Valle d'Aosta, l'inserimento deve essere preventivamente comunicato/autorizzato dall'Azienda Sanitaria locale di residenza.

3. Piano di assistenza individualizzato/integrato

L'assistenza all'utente dell'UAP è fornita sulla base di uno specifico piano individualizzato/integrato nel quale sono definiti gli obiettivi di salute, il percorso assistenziale, la durata del progetto, le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Lo sviluppo del piano di assistenza individualizzato/integrato, nonché le prestazioni di assistenza sanitaria di base, devono essere garantiti dalla presenza di un medico nella struttura. Le prestazioni di assistenza specialistica sono assicurate dai medici specialisti del SSR secondo modalità definite a livello aziendale.

L'unità UAP deve essere dotata di cartella/fascicolo per ciascun ospite in formato elettronico, contenente la relativa documentazione socio-sanitaria, comprensiva del Progetto di Assistenza Individualizzato/Integrata.

L'Unità deve altresì adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico.

L'Unità UAP può essere organizzata anche in nuclei con numero di posti letto inferiore a 20.

4. Dotazione di personale

L'UAP deve disporre del seguente personale addetto all'assistenza degli ospiti:

- Direttore sanitario;
- Medico di struttura (almeno15 minuti/utente/die e nel corso della giornata una disponibilità per eventuali necessità emergenti (quali ad es. nuovi ricoveri, dimissioni, revisione terapia, emotrasfusioni e somministrazioni di terapie o interventi sanitari che necessitano della presenza medica));
- Infermiere incaricato di funzione organizzativa;
- Infermiere (72 minuti a utente al giorno);
- Operatore socio-sanitario / Assistente infermiere non inferiore a 240 minuti a utente al giorno;
- Fisioterapista (18 min a utente al giorno);
- Logopedista in relazione al bisogno degli ospiti.

Le urgenze e le emergenze cliniche dalle ore 20 alle ore 8 sono garantite dal servizio di emergenza territoriale (112).

Il numero degli infermieri dovrà comunque essere tale da garantire la copertura delle 24 ore e tale da assicurare almeno un infermiere costantemente presente per ogni turno.

Oltre ai professionisti addetti alla cura della persona, è prevista la presenza di altri operatori per le attività di supporto (quali ad es. personale amministrativo, attività domestico-alberghiere, etc.).

In presenza di strutture convenzionate/esternalizzate, l'Azienda mantiene la governance dei processi clinico-assistenziali anche al fine di valutare la qualità assistenziale del servizio erogato. L'Azienda governa l'assegnazione degli utenti per il tramite della COT, la predisposizione e attuazione dei PAI, il progetto di dimissione e l'autorizzazione delle proroghe di degenza. I termini della suddetta governance sono definiti nell'ambito dei relativi accordi contrattuali.

5. Collaborazioni con altri servizi sanitari

L' UAP, pur avendo autonomia funzionale, si avvale dei seguenti altri servizi sanitari e sociali:

- emergenza territoriale 112;
- servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostico specialistica assicurati dai medici specialisti aziendali;
- servizio sociale aziendale;
- servizi di telemedicina, in raccordo con la rete territoriale.

6. Tariffa giornaliera

La tariffa per il ricovero presso l'UAP, pari ad euro 270,00 al giorno, è interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la durata dell'inserimento.

La tariffa regionale sopra definita è da intendersi omnicomprensiva degli oneri per l'erogazione dell'assistenza di cui trattasi, quali:
- i costi diretti assistenziali (direttore sanitario, medico di struttura, infermiere con incarico di funzione organizzativa, infermieri, OSS, personale con funzione riabilitativa, dispositivi medici e farmaci);
- i costi dei servizi di supporto diretti (quali ad esempio lo smaltimento rifiuti, i costi per la mensa degli utenti);
- i costi indiretti generali e amministrativi.

I costi afferenti a ogni ulteriore eventuale attività non ricompresa nella tariffa ed eventuali forme di collaborazione nell'erogazione delle prestazioni presso il nucleo UAP dovranno essere oggetto di specifici accordi tra l'ente gestore e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Nei casi di accoglienza di persone non residenti sul territorio regionale, l'addebito della tariffa per il periodo di inserimento avviene mediante fatturazione diretta da parte della struttura all'ASL di residenza dell'utente, previa comunicazione/richiesta di autorizzazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, all'ASL di residenza medesima.

7. Qualità e valutazione

Il Direttore sanitario dell'UAP predispone annualmente un piano di qualità corredato da programmi specifici e indicatori in grado di misurare i risultati ottenuti. Il servizio deve essere sottoposto ad un sistema annuale di verifica dei risultati conseguiti che consenta alla Direzione sanitaria di modificare e/o adattare l'organizzazione del servizio stesso a seconda dei risultati ottenuti. La struttura che ospita l'UAP deve adottare altresì la "carta dei servizi", che contenga le informazioni previste dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, al fine di assicurare la più corretta ed ampia informazione sulle prestazioni offerte.

8. Sistema informativo

La struttura che ospita il nucleo UAP deve essere dotata di un sistema informativo preposto alla raccolta dei dati relativi all'attività erogata, anche in previsione dell'eventuale trasmissione dei medesimi, quale debito informativo, alla Regione e/o all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Le modalità per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi relativi all'attività erogata, sono definiti nell'ambito degli eventuali accordi contrattuali tra i soggetti erogatori dell'attività medesima e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

9. Eventuali ulteriori requisiti per l’unità socio-sanitaria UAP

A corollario dei trattamenti erogati presso l’unità socio-sanitaria sopra descritta, è dato altresì valore alla presenza dei seguenti eventuali ulteriori elementi e requisiti:

- l'attitudine della struttura a favorire la continuità di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunità in cui la struttura stessa è inserita;
- la congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- l’attitudine della struttura a contenere al proprio interno più nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni.
- la dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza delle persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente;
- soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 862 in data 7 luglio 2025

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA DI CURE RESIDENZIALI ESTENSIVE.

1. Tipologia di assistenza e obiettivi

L'Unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive accoglie, di norma, utenti nella fascia di età adulta e anziana, a seguito di dimissione dall'Ospedale regionale, da altre strutture ospedaliere o residenziali, anche extra-regionali oppure provenienti dal domicilio. L'Unità eroga attività riconducibile al codice R2, individuato nel documento tecnico elaborato dalla *Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza* (2007), ovvero prestazioni erogate in nuclei specializzati (Unità di cure residenziali estensive) a pazienti non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria.
Con riferimento alle disposizioni di cui al DPCM 12 gennaio 2017, l'assistenza erogata presso l'Unità deve garantire quanto indicato nell'articolo 30, comma 1, lettera a), il quale prevede trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono un'elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.

I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo.

L'eleggibilità degli utenti in questo setting assistenziale è valutata considerando anche i criteri di inclusione:

- stabilità clinica;
- iter diagnostico concluso.

L'Unità R2 può essere organizzata anche in nuclei con numero di posti letto inferiore a 20.

2. Modalità di inserimento/accesso e durata dell'inserimento

Nell'ambito dell'attività svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale gli inserimenti presso l'Unità socio-sanitaria R2 sono disposti dalla Centrale Operativa Territoriale (COT), nel rispetto dei criteri di eleggibilità dell'utente segnalato dal medico inviante (medico specialista ospedaliero anche extra regionale o medico di medicina generale se l'utente proviene dal domicilio o dalle strutture socio-assistenziali).

Possono essere inseriti presso l'Unità socio-sanitaria utenti provenienti da:

- strutture ospedaliere, strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche extra regionali;
- domicilio.

L'inserimento presso l'Unità R2 è subordinato all'iscrizione dell'utente al Servizio Sanitario Regionale e, allorquando gli utenti non siano residenti in Valle d'Aosta, l'inserimento deve essere preventivamente comunicato/autorizzato dall'Azienda Sanitaria locale di residenza.

La durata massima dell'inserimento presso l'Unità socio-sanitaria R2 è pari a 30 giorni, al termine dei quali l'utente rientra al domicilio se le condizioni cliniche lo permettono oppure è inserito presso un altro setting residenziale, quale ad esempio, previa valutazione dell'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), quello residenziale socio-assistenziale.

È possibile una proroga di ulteriori 30 giorni, su indicazione clinica proposta dal medico di struttura e autorizzata dal Direttore sanitario.

In presenza di strutture convenzionate/esternalizzate, la proroga deve essere avvallata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

3. Piano di Assistenza Individualizzato/Integrato (PAI)

Il PAI definisce gli obiettivi terapeutici, assistenziali e riabilitativi ed è redatto dall'équipe multiprofessionale presente in struttura che valuta il possibile coinvolgimento del *caregiver* e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di pianificare la dimissione favorendo la 'Casa come primo luogo di cura'. Il case manager infermieristico, quale riferimento per l'ospite, promuove la rivalutazione periodica del Piano di Assistenza Individualizzato/Integrato (PAI) in base all'evoluzione dei bisogni dell'assistito, con l'obiettivo di pianificare una dimissione tempestiva e verso il setting più appropriato.

L'unità R2 deve essere dotata di cartella/fascicolo per ciascun ospite in formato elettronico, contenente la relativa documentazione socio-sanitaria, comprensiva del Progetto di Assistenza Individualizzato/Integrata.

L'Unità deve adempiere altresì agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico.

4. Personale

Le figure professionali presenti all'interno dell'Unità R2 e il monte-ore che le medesime devono prestare, individuato con riferimento alle disposizioni nazionali, è riepilogato come segue:

- Direttore Sanitario
- Medico di struttura (8 min/die per utente e nel corso della giornata una disponibilità per eventuali necessità emergenti (quali ad es. nuovi ricoveri, dimissioni, revisione terapia, emotrasfusioni e somministrazioni di terapie o interventi sanitari che necessitano della presenza medica));
- Infermiere incaricato di funzione organizzativa;
- Infermieri (72 min/die per utente);
- Operatore socio-sanitario/Assistente infermiere non inferiore a 132 min;
- Fisioterapista (18 min/die per utente) per 6/7 giorni, fatte salve indicazioni cliniche differenti;
- Logopedista in relazione al bisogno degli ospiti.

Le urgenze e le emergenze cliniche dalle ore 20 alle ore 8 sono garantite dal servizio di emergenza territoriale (112).

Il numero degli infermieri dovrà comunque essere tale da garantire la copertura delle 24 ore e tale da assicurare almeno un infermiere costantemente presente per ogni turno.

Oltre ai professionisti addetti alla cura della persona, è prevista la presenza di altri operatori per le attività di supporto (quali ad es. personale amministrativo, attività domestico-alberghiere, etc.).

In presenza di strutture convenzionate/esternalizzate, l'Azienda mantiene la governance dei processi clinico-assistenziali anche al fine di valutare la qualità assistenziale del servizio erogato. L'Azienda governa l'assegnazione degli utenti per il tramite della COT, la predisposizione e attuazione dei PAI, il progetto di dimissione e l'autorizzazione delle proroghe di degenza. I termini della suddetta governance sono definiti nell'ambito dei relativi accordi contrattuali.

5. Collaborazioni con altri servizi sanitari

L'Unità R2, pur avendo autonomia funzionale, si avvale dei seguenti altri servizi sanitari e sociali:

- emergenza territoriale 112;
- servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostico specialistica assicurati dai medici specialisti aziendali;
- servizio sociale aziendale;
- servizi di telemedicina, in raccordo con la rete territoriale.

6. Tariffa giornaliera

La tariffa per il ricovero presso l'Unità socio-sanitaria di cure estensive è pari ad euro 200,00 al giorno interamente a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per la durata dell'inserimento.
La tariffa regionale sopra definita è da intendersi omnicomprensiva degli oneri per l'erogazione dell'assistenza di cui trattasi, quali:

- i costi diretti assistenziali (direttore sanitario, medico di struttura, infermiere incaricato di funzione organizzativa, infermieri, OSS, altro personale con funzione riabilitativa, dispositivi medici e farmaci);

- i costi dei servizi di supporto diretti (quali ad esempio lo smaltimento rifiuti, i costi per la mensa degli utenti);

- i costi indiretti generali e amministrativi.

I costi afferenti a ogni ulteriore eventuale attività non ricompresa nella tariffa ed eventuali forme di collaborazione nell'erogazione delle prestazioni presso il nucleo R2 dovranno essere oggetto di specifici accordi tra l'ente gestore e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Nei casi di accoglienza di persone non residenti sul territorio regionale, l'addebito della tariffa per il periodo di inserimento avverrà con fatturazione diretta da parte della struttura all'ASL di residenza dell'utente, previa comunicazione/richiesta di autorizzazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta all'ASL di residenza medesima.

7. Qualità e valutazione

Il Direttore sanitario dell'Unità socio-sanitaria predispone annualmente un piano di qualità corredato da programmi specifici e indicatori in grado di misurare i risultati ottenuti. Il servizio deve essere sottoposto ad un sistema annuale di verifica dei risultati conseguiti che consenta alla Direzione sanitaria di modificare e/o adattare l'organizzazione del servizio stesso a seconda dei risultati ottenuti. La struttura che ospita l'Unità socio-sanitaria deve adottare altresì la "carta dei servizi", che contenga le informazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, al fine di assicurare la più corretta ed ampia informazione sulle prestazioni offerte.

8. Flusso di attività degli inserimenti presso l'Unità socio-sanitaria.

La struttura che ospita il nucleo R2 deve essere dotata di un sistema informativo preposto alla raccolta dei dati relativi all'attività erogata, anche in previsione dell'eventuale trasmissione dei medesimi, quale debito informativo, alla Regione e/o all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Le modalità per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi relativi all'attività erogata, sono definiti nell'ambito degli eventuali accordi contrattuali tra i soggetti erogatori dell'attività medesima e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

9. Eventuali ulteriori requisiti per l'unità socio-sanitaria R2

A corollario dei trattamenti erogati presso l'unità socio-sanitaria sopra descritta, è dato altresì valore alla presenza dei seguenti eventuali ulteriori elementi e requisiti:

- l'attitudine della struttura a favorire la continuità di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunità in cui la struttura stessa è inserita;
- la congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- l'attitudine della struttura a contenere al proprio interno più nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni.
- la dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza delle persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente;
- soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 862 in data 7 luglio 2025

REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA DI LUNGOASSISTENZA E MANTENIMENTO, ANCHE DI TIPO RIABILITATIVO, EROGATE A PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI CON BASSA NECESSITÀ DI TUTELA SANITARIA (UNITÀ DI CURE RESIDENZIALI DI MANTENIMENTO).

1. Tipologia di assistenza e obiettivi

Le strutture dedicate ai trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, anche di tipo riabilitativo, erogano attività socio-sanitaria rivolta a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. Presso tale struttura si possono prevedere anche accoglienze temporanee finalizzate a dare sollievo ai familiari/*caregiver* di persone non autosufficienti. L'attività dell'Unità socio-sanitaria di cui trattasi è riconducibile al codice R3 individuato nel documento tecnico elaborato dalla *Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza* (2007).

Con riferimento alle disposizioni di cui al DPCM 12 gennaio 2017, l'assistenza erogata presso l'Unità deve garantire quanto indicato nell'articolo 30, comma 1, lettera b), il quale prevede trattamenti a persone non autosufficienti adulte e anziane.

L'Unità R3 può essere organizzata anche in nuclei con numero di posti letto inferiore a 20.

2. Modalità di inserimento/accesso e durata dell'inserimento

Nell'ambito dell'attività svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, l'accesso all'Unità socio-sanitaria è subordinato alla verifica dell'effettiva appropriatezza, stabilita sulla base di criteri oggettivi di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente e segue le modalità previste per le unità UAP e R2, includendo l'attività di coordinamento da parte della Centrale Operativa Territoriale (COT).

L'Unità socio-sanitaria R3 accoglie persone che provengono dall'ospedale per acuti, da una struttura di post-acuzie o dal domicilio.

La durata dell'inserimento è stabilita dal Piano di assistenza individualizzato/integrato (PAI).

L'unità R3 deve essere dotata di cartella/fascicolo per ciascun ospite in formato elettronico, contenente la relativa documentazione socio-sanitaria, comprensiva del Progetto di Assistenza Individualizzato/Integrata.

L'Unità deve adempiere altresì agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico.

3. Piano di assistenza individualizzato/integrato (PAI)

Il PAI definisce gli obiettivi terapeutici, assistenziali e riabilitativi ed è redatto dall'équipe multiprofessionale presente in struttura che valuta il possibile coinvolgimento del *caregiver* e della rete dei servizi territoriali alfine di pianificare la dimissione favorendo la 'Casa come primo luogo di cura'. Il *case manager* nella persona dell'infermiere di riferimento dell'ospite, promuove la rivalutazione del PAI in relazione al variare dei bisogni dell'assistito o comunque semestralmente.

4. Personale

Le figure professionali presenti all'interno dell'Unità socio-sanitaria R3 e il monte-ore che le medesime devono prestare, individuato anche con riferimento alle disposizioni nazionali, è riepilogato come segue:

- Responsabile medico di struttura/Direttore sanitario;
- Medico responsabile della gestione clinica del singolo ospite in base alle necessità dei pazienti (medico di medicina generale se non diversamente individuato);
- Infermiere incaricato di funzione organizzativa;
- Infermiere almeno H8
- Operatore socio-sanitario / Assistenza globale non inferiore a 100 min

Le urgenze e le emergenze cliniche dalle ore 20 alle ore 8 sono garantite dal servizio di emergenza territoriale (112).

Il numero delle ulteriori figure professionali di riabilitazione, educativo/animative e altre ancora è definito in relazione alle dimensioni della struttura, ai volumi delle attività erogate e al bisogno assistenziale degli ospiti.

5. Collaborazioni con altri servizi sanitari

L'unità socio sanitaria R3, pur avendo autonomia funzionale, si avvale dei seguenti altri servizi sanitari e sociali:

- emergenza territoriale 112;
- servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e diagnostico specialistica assicurati dai medici specialisti aziendali;
- servizio sociale del territorio di competenza;
- servizi di telemedicina, in raccordo con la rete territoriale.

In presenza di strutture convenzionate/esternalizzate, l'Azienda mantiene la governance dei processi clinico-assistenziali anche al fine di valutare la qualità assistenziale del servizio erogato. L'Azienda governa l'assegnazione degli utenti per il tramite della COT, la predisposizione e attuazione dei PAI, il progetto di dimissione e l'autorizzazione delle proroghe di degenza. I termini della suddetta governance sono definiti nell'ambito dei relativi accordi contrattuali.

6. Tariffa giornaliera

La tariffa per il ricovero presso l'Unità socio-sanitaria è pari ad euro 150,00 al giorno.
La tariffa regionale sopra definita è da intendersi omnicomprensiva degli oneri per l'erogazione dell'assistenza di cui trattasi, quali:

- i costi diretti assistenziali (responsabile medico di struttura/direttore sanitario, infermiere incaricato di posizione organizzativa, infermieri, OSS, altro personale con funzione riabilitativa, dispositivi medici e farmaci);

- i costi dei servizi di supporto diretti (quali ad esempio lo smaltimento rifiuti, i costi per la mensa degli utenti);

- i costi indiretti generali e amministrativi.

I costi afferenti a ogni ulteriore eventuale attività non ricompresa nella tariffa ed eventuali forme di collaborazione nell'erogazione delle prestazioni presso il nucleo R3 dovranno essere oggetto di specifici accordi tra l'ente gestore e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

I trattamenti di lungoassistenza, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, del DPCM 12 gennaio 2017, sono a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per una quota pari al 50%, il restante 50% è a carico del paziente/dei familiari.

Ai sensi dell'articolo 19, della l.r. 23 luglio 2010, n. 23, è prevista la possibilità di erogazione di contributi economici per il pagamento della quota a carico dell'utente, a favore di persone non autosufficienti affette da gravi patologie invalidanti, che non possono permanere al proprio domicilio.

Nei casi di accoglienza di persone non residenti sul territorio regionale, l'addebito della tariffa per il periodo di inserimento avverrà con fatturazione diretta da parte della struttura all'ASL di residenza dell'utente, previa comunicazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, all'ASL di residenza medesima.

7. Qualità e valutazione

Il Responsabile medico della struttura/Direttore sanitario predispone annualmente un piano di qualità corredato da programmi specifici e indicatori in grado di misurare i risultati ottenuti. Il servizio deve essere sottoposto ad un sistema annuale di verifica dei risultati conseguiti che consenta al Responsabile medico/Direttore sanitario di modificare e/o adattare l'organizzazione del servizio stesso a seconda dei risultati ottenuti.
La struttura che ospita l'Unità socio-sanitaria deve adottare altresì la "carta dei servizi", che contenga le informazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia, al fine di assicurare la più corretta ed ampia informazione sulle prestazioni offerte.

8. Flusso di attività degli inserimenti presso l'Unità socio-sanitaria R3

La struttura che ospita il nucleo R3 deve essere dotata di un sistema informativo preposto alla raccolta dei dati relativi all'attività erogata, anche in previsione dell'eventuale trasmissione dei medesimi, quale debito informativo, alla Regione e/o all'Azienda USL della Valle d'Aosta.
Le modalità per la rilevazione e trasmissione dei flussi informativi relativi all'attività erogata, sono definiti nell'ambito degli eventuali accordi contrattuali tra i soggetti erogatori dell'attività medesima e l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

9. Eventuali ulteriori requisiti per l'unità socio-sanitaria R3

A corollario dei trattamenti erogati presso l'unità socio-sanitaria sopra descritta, è dato altresì valore alla presenza dei seguenti eventuali ulteriori elementi e requisiti:

- l'attitudine della struttura a favorire la continuità di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunità in cui la struttura stessa è inserita;
- la congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi previsti dalle disposizioni vigenti;
- l'attitudine della struttura a contenere al proprio interno più nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni.
- la dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l'implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza delle persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente;
- soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l'erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118.